

1. Чоловік віком 78 років шпиталізований до відділення ВАІТ через годину після появи нечіткого мовлення та асиметрії обличчя. Об'єктивно спостерігається: за ШКГ - 15 балів, АТ - 195/100 мм рт. ст., пульс - 90/хв, ритмічний. Під час неврологічного огляду виявлено: центральний парез мимічних м'язів обличчя праворуч. Яка подальша тактика введення пацієнта?

- А. Терміново призначити в/в актилізе
- В. Призначити пацієнту аспірин
- С. Здійснити КТ головного мозку
- Д. Призначити антикоагулянти
- Е. Негайно знизити АТ

2. Хлопець віком 15 років раптово впав, розвинулися тоніко-клонічні судоми, мимовільне сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: свідомість втрачена, з рота виділяється слина рожевого кольору. Судоми тривали 2 хв, після чого хлопець заснув. Із анамнезу відомо, що в дитинстві були епізоди абсансу. Який попередній діагноз?

- А. Епілептичний статус
- В. Гіпоглікемічна кома
- С. Непритомність
- Д. Генералізований тоніко-клонічний напад
- Е. Субарахноїдальний крововилив

3. Жінка віком 53 роки скаржиться на тремтіння верхніх кінцівок, скутість при ходьбі, часті падіння, епізоди нетримання сечі. Ефект від застосування препаратів леводопи оцінює як незначний. У неврологічному статусі визначаються гіпомімія, олігобрадигіпокінезія, симетричний тремор спокою у верхніх кінцівках, позитивний симптом Нойка білатерально. Пасивна ортостатична проба позитивна. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- А. Хвороба Галевордена-Шпатца
- В. Мультисистемна атрофія
- С. Кортикобазальна дегенерація
- Д. Хвороба Паркінсона
- Е. Супрануклеарний параліч

4. Пацієнт віком 34 роки, який із дитинства хворіє на епілепсію, шпиталізований до лікарні після серії генералізованих судомних нападів, між якими не приходив до тями. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- А. Синкопальний стан
- В. Кома І
- С. Гостре порушення мозкового кровообігу
- Д. Менінгоенцефаліт
- Е. Епілептичний статус

5. Чоловік віком 48 років шпиталізований до відділення реанімації та інтенсивної терапії з порушенням свідомості. Під час огляду спостерігається: на звернене мовлення розплющує очі, дезорієнтований, відповідь не адекватна запитанню, на больові подразники посмикує кінцівки. Скільки балів за шкалою ком Глазго у цього пацієнта?

- А. 10-11
- В. 5-6
- С. 13-14
- Д. 7-8
- Е. 4-5

6. У жінки віком 38 років поступово розвивалися атактичні та пірамідні порушення, проведено МРТ головного мозку. Отримані результати показали множинні ділянки округлої та овальної форми, переважно з чіткими контурами без вираженого перифокального набряку, розмірами від 4х4 мм до 18х23 мм у підкіркових відділах обох гемісфер мозку, перивентрикулярно, у променистих вінцях у мозолистому тілі, лівій ніжці мозку та у лівій гемисфері мозочка. Для якого патологічного стану характерні зміни, що були виявлені на МРТ головного мозку?

- А. Розсіяного склерозу
- В. Фунікулярного мієлозу
- С. Хвороби Лайма
- Д. Множинного метастатичного ураження головного мозку
- Е. Хвороби Бінсвагнера

7. Чоловік віком 38 років після тривалого перебування в вертикальному положенні у задушливому приміщенні раптово зблід, короткочасно втратив свідомість. Яка найімовірніша причина патологічного стану пацієнта?

- А. Субарахноїдальний крововилив
- В. Транзиторна ішемічна атака в судинах ВББ
- С. Інфаркт міокарда
- Д. Складний парціальний епінапад
- Е. Колапс

8. Чоловік віком 40 років доставлений бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу. За результатами комп'ютерної томографії виявлено крововилив у ділянці правої половини моста мозку. Який судинний басейн уражено у пацієнта?

- A. Задня сполучна артерія
- B. Хребетна артерія праворуч
- C. Середня мозкова артерія праворуч
- D. Задня мозкова артерія праворуч
- E. Основна артерія

9. До неврологічного відділення звернувся пацієнт зі скаргами на раптову появу двоїння в очах, що посилюється під час спроби відвести погляд вліво. Під час огляду виявлена збіжна косоокість ліворуч. Який черепний нерв та який окоруховий м'яз, що ним іннервується, зазнали ураження?

- A. Лівий окоруховий нерв, зовнішній прямий м'яз
- B. Правий відвідний нерв, зовнішній прямий м'яз
- C. Лівий відвідний нерв, внутрішній прямий м'яз
- D. Лівий відвідний нерв, зовнішній прямий м'яз
- E. Лівий окоруховий нерв, внутрішній прямий м'яз

10. Жінка віком 70 років після пробудження виявила слабкість правих кінцівок, розлад мовлення, порушення чутливості у правій половині тіла. Артеріальний тиск - 100/60 мм рт. ст. У неврологічному статусі визначаються правобічні центральний геміпарез та гемігіпалгезія, моторна афазія. Який попередній діагноз?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Пухлина головного мозку
- C. Енцефаліт
- D. Геморагічний інсульт
- E. Субарахноїдальний крововилив

11. Чоловік віком 65 років хворіє на ІХС, артеріальну гіпертензію та фібриляцію передсердь. Відомо, що два тижні тому перестав вживати антиаритмічні препарати і раптово втратив здатність розуміти мовлення, не може виконати прості накази. За результатами МРТ головного мозку виявлено обмеження дифузії в задньому

відділі лівої верхньої скроневий звивини. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Ішемічний атеротромботичний інсульт
- B. Ішемічний кардіоемболічний інсульт
- C. Лакунарний інфаркт мозку
- D. Об'ємне новоутворення головного мозку
- E. Паренхіматозний крововилив

12. Чоловік віком 36 років скаржиться на слабкість у кінцівках, головний біль, нудоту, було дворазове блювання. Об'єктивно спостерігається: зіниці вузькі, фотореакція зіниць млява, загальний гіпергідроз, підвищене слиновиділення. У сироватці крові виявлено зниження активності холінестерази. Із анамнезу відомо, що протягом дня зважував хімічні реактиви без респіратору. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Отруєння бензином
- B. Гостра інтоксикація фосфорорганічними сполуками
- C. Харчова токсикоінфекція
- D. Отруєння ртуттю
- E. Отруєння миш'яковими пестицидами

13. Під час неврологічного огляду чоловіка віком 25 років виявлено: вазомоторні розлади, розлади зору (геміанопсія, набряк дисків зорових нервів), птоз, розбіжну косоокість та депресивний синдром. На рентгенограмі черепа - утворення в ділянці турецького сідла. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Мігрень без аури
- B. Інсульт у стовбурі мозку
- C. Аденома гіпофіза
- D. Синдром вегетативної дисфункції
- E. Розсіяний склероз

14. У пацієнта після травми плеча з'явилася слабкість м'язів дистального відділу лівої руки, гіпотрофія м'язів та біль лівої кисті. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Шийна радикулопатія
- B. Сирингомієлія
- C. Синдром 'плече-кисть'
- D. Нижній плечовий плексит Дежеріна-Клюмпке
- E. Бічний аміотрофічний склероз

15. Укажіть препарат першої лінії для лікування судомного епілептичного статусу.

- A. Карбамазепін

- В. Тіопентал натрію
- С. Пропофол
- D. Діазепам**
- Е. Фенобарбітал

16. У чоловіка віком 42 роки працює будівельником, під час підйому вантажу виник гострий біль у попереку з іррадіацією болю по задній поверхні лівого стегна. У неврологічному статусі виявлено: виражена болючість паравертебральних точок у поперековому відділі, напруження довгих м'язів спини, гіпалгезія по зовнішній поверхні лівої гомілки та стопи, м'язова слабкість у розгиначах пальців лівої ноги, зниження ахілового рефлексу ліворуч. Який патогенетичний механізм захворювання?

- А. Гостра компресія кінського хвоста
- В. Гостра компресія корінців L5-S1**
- С. Подразнення синуввертебрального нерва Люшки
- Д. Гостра компресія артерії Депрож-Готтерона
- Е. Гостра радикулоішемія L5

17. Жінка віком 34 роки скаржиться на напади гострого, стріляючого болю в ділянці зовнішнього слухового ходу. Біль виникає декілька разів на день протягом 3-х місяців. Подібний стан з'являється 1 раз на рік. Яке захворювання може запідозрити лікар у пацієнтки?

- А. Невралгію язикоглоткового нерва
- В. Невралгію трійчастого нерва
- С. Невралгію слухового нерва
- Д. Кластерний головний біль
- Е. Невралгію барабанного нерва**

18. Пацієнта турбує короточасний напад гострого болю у половині верхньої губи та щелепи з правого боку, провокується жуванням, сміхом, супроводжується больовою гримасою. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Мігрень
- В. Одонтогенний лицевий біль
- С. Невралгія крилопіднебінного вузла
- Д. Невралгія трійчастого нерва**
- Е. Дентальна плексалгія

19. Чоловіка віком 33 роки після ДТП шпиталізовано до відділення невідкладної допомоги без свідомості. Об'єктивно спостерігається: анізокорія, свідомість на рівні коми І, тонус м'язів симетрично знижений, патологічних рефлексів не виявлено. За результатами КТ головного

мозку виявлено гіперінтенсивне вогнище на конвекситальній поверхні мозку у формі лінзи. Про розвиток якої патології свідчать отримані дані?

- А. Варіант норми
- В. Внутрішньомозкового крововиливу
- С. Субдуральної гематоми
- Д. Епідуральної гематоми**
- Е. Субарахноїдального крововиливу

20. У жінки віком 42 роки під час огляду спостерігається: прозопарез ліворуч, відсутній лівий надбрівний рефлекс, сухість лівого ока. Укажіть місце ураження лицевого нерва.

- А. До відходження барабанної струни
- В. До відходження стремінцевого нерва
- С. При виході з шило-соскоподібного отвору
- Д. Після відходження великого кам'янистого нерва
- Е. До відходження великого кам'янистого нерва**

21. Хлопець віком 19 років скаржиться на хиткість під час ходьби. Вперше порушення координації виникли 5 років тому. З того часу відзначає поступове погіршення стану у вигляді збільшення вираженості розладів координації. Неврологічний статус: за ШКГ - 15 балів, горизонтальний крупнорозмашистий ністагм із ротаторним компонентом, скандоване мовлення, в пробі Ромберга падає, виражена інкоординація при виконанні пальце-носових та п'ятково-колінних проб білатерально, дисметрія, дисдіадохокінез, дифузна м'язова гіпотонія, зниження м'язово-суглобового відчуття в нижніх кінцівках, деформація грудної клітки та стоп. Патологічний змін за даними МРТ головного не виявлено. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Мультисистемна атрофія (мозочковий підтип)
- В. Хвороба Фрідрейха**
- С. Атаксія П'єра-Марі
- Д. Атаксія Марі-Фуа-Алажуаніна
- Е. Синдром Луї-Бар

22. У чоловіка віком 67 років, що тривало хворіє на артеріальну гіпертензію та фібриляцію передсердь, раптово виникло двоїння при погляді вліво, асиметрія обличчя та слабкість у правих кінцівках. Об'єктивно спостерігається: збіжна косоокість за рахунок OS, лівобічний

прозопарез та центральний правобічний геміпарез. Укажіть назву альтернуючого синдрому?

- A. Бріссо-Секара
- B. Бенедикта
- C. Вебера
- D. Фовілля
- E. Мійяра-Гюблера

23. Яке інструментальне дослідження необхідно провести пацієнту для виключення внутрішньомозкового крововиливу в стадії загострення?

- A. ЕЕГ
- B. ПЕТ
- C. КТ
- D. МРТ
- E. Рентгенографію черепа

24. Яка анатомічна структура є покрівлею середнього мозку?

- A. Сітчасте утворення
- B. Мозочок
- C. Огорожа
- D. Ніжки мозку
- E. Чотиригорбикове тіло

25. За допомогою якого з нижченаведених провідних шляхів спинного мозку відбувається передача поверхневої чутливості?

- A. Руброспинального шляху
- B. Шляху Бурдаха
- C. Кірково-спинномозкового шляху
- D. Спинно-таламічного шляху
- E. Шляху Голля

26. У чоловіка віком 70 років після переохолодження виник сильний біль у лівій половині голови в ділянці лоба та лівого ока. Через 3 дні на тлі підвищення температури тіла до 37,6°C з'явилися пухирцеві висипання на чолі ліворуч та на лівій верхній повіці. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Неврит трійчастого нерва
- B. Дерматит
- C. Холодова алергія
- D. Невралгія трійчастого нерва
- E. Герпетичний гангліоніт вузла трійчастого нерва

27. Чоловік віком 37 років скаржиться на подвійня предметів перед очима, асиметрію мимічної мускулатури ліворуч. У неврологічному статусі ліворуч

визначається периферичний прозомонопарез, параліч латерального м'яза ока, праворуч - геміплегія зі збереженням функції мимічних м'язів. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Бріссо-Сікара
- B. Фовілля
- C. Раймона-Сестана
- D. Гасперіні
- E. Мійяра-Гюблера

28. У пацієнта діагностовано гіпотиреоз. Яке неврологічне ускладнення не належить до цього захворювання?

- A. Міопатичний синдром (з псевдогіпертрофіями)
- B. Енцефалопатія
- C. Поліневропатичний синдром
- D. Епілептичний синдром
- E. Міотонічний синдром

29. Під час обстеження, невролог діагностував у пацієнта порушення чутливості на обличчі праворуч за сегментарним типом у зонах Зельдера. Ураженням яких структур та на якому рівні можна пояснити виявлені зміни?

- A. Ядра спинномозкового тракту трійчастого нерва на рівні довгастого мозку
- B. Гассерового вузла
- C. Корінця трійчастого нерва в мосто-мозочковому куті
- D. Термінального ядра трійчастого нерва на рівні моста
- E. II та III гілки трійчастого нерва на обличчі

30. У пацієнта з гострим порушенням мозкового кровообігу у вертебробазиллярному басейні під час неврологічного огляду виявлено ністагм при погляді праворуч, інтенційний тремор під час виконання пальце-носової та п'яtkово-колінної проб правими кінцівками й адіадохокінез у правій руці. Яка з нижченаведених структур була уражена?

- A. Права половина моста
- B. Ліва півкуля мозочка
- C. Ліва половина довгастого мозку
- D. Права півкуля мозочка
- E. Ліва половина моста

31. У пацієнтки віком 32 роки після народження дитини з'явилася слабкість у ногах та похитування при ходьбі. Із

анамнез відомо, що 2 роки тому було зниження зору, яке регресувало без лікування. Який попередній діагноз?

- A. Пухлина задньої черепної ямки
- B. Нейросифіліс
- C. Розсіяний склероз
- D. Інфаркт мозку в судинах ВББ
- E. Спиноцеребелярна атаксія

32. У хлопця віком 27 років упродовж 4-х років поступово виникла слабкість у ногах, змінилася ходьба, розвинувся гіперлордоз поперекового відділу хребта. Об'єктивно спостерігається: центральний нижній легкий паразез із високим тонусом, деформація стоп. Чутливих та вегетативних порушень не виявлено. Зі слів пацієнта, подібне захворювання є у батька. Про яке захворювання нервової системи йдеться?

- A. Спадкова полінейропатія Шарко-Марі-Тута
- B. Бічний аміотрофічний склероз
- C. Гострий РЕМ, форма дисемінованого мієліту
- D. Спінальна форма розсіяного склерозу
- E. Спадкова спастична паралегія Штрюмпеля

33. У дівчини віком 24 роки - клінічні ознаки розсіяного склерозу. Який метод дослідження дозволить виявити вогнища демієлінізації?

- A. МРТ із контрастним підсиленням
- B. ПЕТ
- C. Люмбальна пункція
- D. КТ із контрастним підсиленням
- E. ЕЕГ

34. Укажіть симптом, який вказує на пошкодження окорухового нерва та відсутній під час ураження його ядер.

- A. Поява центрального парезу протилежних кінцівок
- B. Відсутній провідниковий руховий розлад у протилежних кінцівках
- C. Відсутність прямої реакції зіниці на світло за збереження співдружності
- D. Наявність збіжної косоокості та диплопії
- E. Наявність птозу верхньої повіки та мідріазу

35. У пацієнта віком 36 років під час неврологічного огляду спостерігається: гіперакузія з порушенням чутливості на

передніх 2/3 язика, прозопарез праворуч. Який нерв уражений?

- A. Під'язиковий
- B. Трійчастий
- C. Блукаючий
- D. Лицевий
- E. Язикоглотковий

36. Пацієнт віком 47 років, в анамнезі якого гіпертонія й атеросклеротичне ураження сонних артерій, звернувся зі скаргами на неможливість розгинання правої кисті, обмеження відведення великого пальця вбік, зниження чутливості на тильній поверхні I та II пальців. Скарги виникли раптово після сну, напередодні вживав велику кількість алкоголю. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Гостре лакунарне порушення мозкового кровообігу
- B. Компресійна мононевропатія променевого нерва
- C. Компресійна радикулопатія шийного відділу хребта
- D. Гостра запальна демієлінізуюча полірадикулопатія
- E. Компресійна радикулопатія грудного відділу хребта

37. У чоловіка віком 38 років, після підняття вантажу раптово виник інтенсивний головний біль, стався генералізований білатеральний тоніко-клонічний судомний напад. Об'єктивно спостерігається: позитивний вилічний феномен Бехтерева, ригідність м'язів потилиці 3 см, симптом Керніга 60° двобічно. Який метод обстеження слід призначити для верифікації діагнозу?

- A. МРТ головного мозку
- B. Дуплексне сканування судин головного мозку
- C. КТ головного мозку
- D. Фундоскопію
- E. Люмбальну пункцію

38. У чоловіка із діагнозом: новоутворення головного мозку раптово погіршився загальний стан та виникли скарги на виражений головний біль. Об'єктивно спостерігається: нестримне блювання, що не приносить полегшення, зниження АТ - до 80/50 мм рт. ст., брадикардія - 38/хв, мідріаз, симптом Паріно. Яке ускладнення основного захворювання виникло в пацієнта?

- A. Дислокаційний синдром
- B. Синдром Фостера-Кенеді
- C. Оболонковий синдром
- D. Інтоксикаційний синдром
- E. Паранеопластичний синдром

39. Чоловік віком 76 років на тлі помірного цефалгічного синдрому помітив появу розладів мовлення, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, ІХС, інфаркт міокарда, пароксизмальна форма фібриляції передсердь. У неврологічному статусі: часткова сенсо-моторна афазія, центральний геміпарез та гемігіпалгезія з парезом мімічних м'язів за центральним типом праворуч. Який метод лікування показаний пацієнту?

- A. Декомпресійна краніотомія
- B. Подвійна антиагрегантна терапія
- C. Антикоагулянтна терапія
- D. Вентрикуло-перитонеальне шунтування
- E. Тромболітична терапія

40. Чоловік віком 36 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, оніміння обличчя ліворуч, асиметрію мімічної мускулатури ліворуч, зниження слуху на ліве вухо, слабкість та оніміння в кінцівках з лівого боку. У неврологічному статусі ліворуч визначаються гіпестезія обличчя, збіжна косоокість, лагофталм, ліворуч - геміпарез, гемігіпестезія. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Гасперіні
- B. Мійяра-Гублера
- C. Бріссо-Сікара
- D. Раймона-Сестана
- E. Фовілля

41. У пацієнта спостерігається параліч Дежерін-Клюмпке. Який рівень ушкодження спинного мозку та плечового сплетення викликає цей тип плексопатії?

- A. Верхньої частини сплетення, корінці C5-C6
- B. Нижньої частини сплетення, корінці C5-C6
- C. Нижньої частини сплетення, корінці C8-Th1
- D. Повне ураження плечового сплетення
- E. Нижньої частини сплетення, корінці C4-C8

42. Жінка віком 28 років більше 7-ми років хворіє на розсіяний склероз. Упродовж останніх 3-х днів стан погіршився: наростає

слабкість у ногах, посилилась хиткість під час ходьби. У неврологічному статусі: горизонтальний ністагм, м'язева сила в ногах знижена до 3-х балів, високі сухожилкові рефлекси, клонуси стоп двобічно, симптом Бабінського (+) двобічно, черевні рефлекси не викликаються, хитання в позі Ромберга, інтенційний тремор під час виконання координаторних проб. Який метод лікування загострення захворювання необхідно призначити пацієнці?

- A. Інфузійне моноклональне антитіло
- B. Плазмаферез
- C. Кортикостероїд, пульс-терапія
- D. Антигенспецифічна терапія
- E. Кортикостероїд, пероральне введення

43. Жінка віком 58 років, яка хворіє на артеріальну гіпертензію, раптово під час психоемоційного напруження втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, гіперемія обличчя, пульс - 100/хв, напружений, АТ - 230/110 мм рт. ст. Опущений правий кутик рота, дихання шумне, права щока парусить. Підняті праві кінцівки падають 'як батоги', м'язовий тонус у них та рефлекси знижені, на лівих кінцівках збережені, позитивний симптом Бабінського праворуч. Який попередній діагноз?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Крововилив у ліву півкулю мозку
- C. Менінгіт
- D. Субарахноїдальний крововилив
- E. Інфаркт мозку

44. Пацієнт віком 38 років звернувся по медичну допомогу з приводу епізодів втрати свідомості, які виникають здебільшого під час фізичного навантаження, тривають до 2-3 хв, після чого швидко приходить до тями. Під час обстеження у пацієнта виявлено АВ блокаду II ступеня. Яка найбільш імовірна причина втрати свідомості у пацієнта?

- A. Транзиторні ішемічні атаки
- B. Синкопальні стани
- C. Сопор
- D. Епілептичні напади
- E. Панічний розлад

45. У якій структурі головного мозку розташований центр горизонтально-координованої дії окорухових м'язів?

- A. Середній мозок
- B. Внутрішня капсула

- C. Мозочок
- D. Покришка
- E. Міст

46. Чотирнадцятирічна дівчинка скаржиться на насильницькі рухи в м'язах обличчя, кінцівок. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на гострий тонзиліт 3-4 рази на рік. Лікар встановив попередній діагноз: ревматична хорея. Які ще неврологічні симптоми характерні для цього захворювання?

- A. Пластичний м'язовий тонус, тремор спокою
- B. Знижений тонус м'язів нижніх кінцівок, відсутність колінних рефлексів
- C. Патологічний стопний розгинальний рефлекс Гордона, підвищений тонус м'язів кінцівок
- D. Колінний симптом Гордона-2, знижений тонус м'язів кінцівок
- E. Знижений тонус м'язів, інтенційний тремор

47. Які симптоми характерні для пацієнта з ураженням нижньої тім'яної часточки домінантної півкулі головного мозку?

- A. Соматотопагнозія, геміанестезія, атаксія
- B. Сенсомоторна афазія, дисфагія, геміпарез, гемігіпестезія, підвищення сухожилково-періостальних рефлексів
- C. Однобічне просторове ігнорування
- D. Головний біль, запаморочення
- E. Центральний геміпарез, пальцева агнозія, порушення право-лівого орієнтування, дисграфія, дискалькулія, аутоскопичний феномен

48. Ураження якої ділянки головного мозку призводить до апраксії одягання?

- A. Недомінантної лобної
- B. Домінантної лобної
- C. Домінантної скроневої
- D. Домінантної тім'яної
- E. Недомінантної тім'яної

49. У пацієнта із діагнозом: розсіяний склероз - з'явилася диплопія після одного року ремісії. Яке дослідження необхідно провести для вирішення питання про доцільність призначення пульс-терапії метилпреднізолоном?

- A. МРТ головного мозку з в/в контрастуванням

- B. Аналіз крові на антитіла до ацетилхолінових рецепторів
- C. ЕНМГ
- D. МРТ головного мозку
- E. Огляд очного дна

50. До приймального відділення лікарні доставлено жінку віком 56 років. Відомо, що сьогодні зранку в неї розвинувся генералізований клоніко-тонічний білатеральний судомний напад. Подібний напад був 6 місяців тому. Із анамнезу відомо, що хворіє на гіпертонічну хворобу, 3 роки тому перенесла ЗЧМТ, забій головного мозку. Під час огляду: температура тіла - 36,8°C, АТ - 165/100 мм рт. ст., наявний менінгеальний синдром, елементи моторної афазії, правобічна рефлекторно-пірамідна недостатність. У спинномозковій рідині змін не виявлено, на КТ головного мозку діагностовано лікворну кісту лівої гемісфери розміром 33x17x21 мм, кортико-атрофічні зміни післятравматичного генезу. Призначення якої групи препаратів першої лінії показано пацієнтці?

- A. Транквілізаторів бензодіазепінового ряду
- B. Групи прегабалінів
- C. Габапентинового ряду
- D. Групи антигіпертензивних засобів
- E. Препарати вальпроєвої кислоти

51. Пацієнт із підозрою на субарахноїдальний крововилив шпиталізований до стаціонару. Яке обстеження необхідно провести для термінової нейровізуалізації?

- A. МСКТ головного мозку з в/в контрастуванням
- B. Люмбальну пункцію з цитологічним аналізом ліквору
- C. МРТ головного мозку
- D. Рентгенографію черепа
- E. МСКТ головного мозку

52. Чоловік віком 45 років скаржиться на опущення повік і двоїння в очах, які зникають до ранку. Лікар запідозрив, що у пацієнта міастенія. Який метод дослідження допоможе підтвердити діагноз?

- A. ЕНМГ
- B. КТ
- C. Люмбальна пункція
- D. ЕЕГ
- E. МРТ

53. За допомогою якої шкали проводиться оцінка тяжкості стану пацієнта в гострому періоді ішемічного інсульту?

- A. Індекса Бартел
- B. Ешворта
- C. Гамільтона
- D. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)
- E. MMSE (Mini-Mental State Examination)

54. Пацієнт звернувся до приймального відділення, оскільки випадково випив алкоголь невідомого походження. Назвіть основні клінічні симптоми отруєння метиловим спиртом.

- A. Зниження слуху
- B. Порушення нюху
- C. Психомоторне збудження
- D. Синкопальний стан
- E. Зниження гостроти зору або сліпота

55. У дівчини віком 23 роки вже двічі спостерігалися генералізовані тоніко-клонічні напади, які були зафіксовані на ЕЕГ. Укажіть препарати першої лінії для лікування епілептичних нападів.

- A. Окскарбазепін, топірамат
- B. Фенобарбітал, фенітоїн
- C. Вальпроєва кислота, ламотриджин
- D. Карбамазепін, леветирацетам
- E. Діазепам, габапентин

56. У пацієнта локалізація вогнища ураження - в задньому відділі верхньої скроневої звивини (центр Верніке). Який патологічний стан виникне у пацієнта?

- A. Сенсорна афазія
- B. Зорова агнозія
- C. Алексія
- D. Дизартрія
- E. Моторна афазія

57. Хлопець віком 18 років скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, нудоту, блювоту, підвищення температури тіла до 39°C, біль у м'язах, загальну слабкість, особливо в руках. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому повернувся з практики в селі, де вживав у їжу сире козяче молоко. Об'єктивно спостерігається: мляві парези проксимальних відділів руки, менінгеальні симптоми. Установіть попередній діагноз пацієнту.

- A. Геморагічний інсульт
- B. Кліщовий енцефаліт
- C. Серозний менінгіт

- D. Інфекційний поліневрит
- E. Епідемічний енцефаліт

58. Протягом останніх двох днів чоловік помітив у себе опущення правої повіки, двоїння при погляді прямо, вгору, вниз та до середини. Під час огляду спостерігається: розбіжна косоглядість OD, анізокорія D>S, права зіниця не реагує на світло, порушення акомодатції. Ураження якого черепно-мозкового нерва можна запідозрити?

- A. Зорового
- B. Трійчастого
- C. Блокового
- D. Окорухового
- E. Відвідного

59. Чоловік віком 36 років скаржиться на ниючий біль у лівому передпліччі та кисті, що посилюється під час фізичної роботи. У неврологічному статусі: м'язова гіпотрофія кисті ліворуч, слабкість згиначів, особливо I, II пальців, гіпостезія кисті на долонній поверхні. Установіть попередній діагноз.

- A. Тунельна нейропатія променевого нерва
- B. Полінейропатія
- C. Тунельна нейропатія ліктьового нерва
- D. Вертеброгенний корінцевий синдром C5-C6 ліворуч
- E. Тунельна нейропатія серединного нерва

60. Чоловік віком 30 років скаржиться на раптові епізоди головокружіння, що супроводжуються нудотою та блюванням, тривають 30-60 с та провокуються зміною положення тіла. Лікар запідозрив захворювання: доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння. Який діагностичний метод дозволить підтвердити діагноз?

- A. Маневр Дікса-Холлпайка
- B. МРТ шийного відділу хребта
- C. Дуплекс брахіоцефальних судин
- D. Маневр Еплі
- E. Аудиометрія

61. Жінка віком 24 роки скаржиться на підсилення м'язової слабкості, появу фасцикулярних посмикувань м'язів, біль у животі, слинотечу, пітливість, брадикардію. Із анамнезу відомо, що пацієнтка приймає піридостигмін для контролю міастенії. Укажіть причину патологічного стану пацієнтки.

- A. Епілептична реакція

- В. Міастенічний криз
- С. Симпатоадреналовий криз
- Д. **Холінергічний криз**
- Е. Змішаний вегетативний криз

62. Пацієнт віком 57 років скаржиться на раптову слабкість м'язів однієї половини обличчя, слюзоточивість із того самого боку та зміни смаку. Встановлено попередній діагноз: ідіопатичний параліч лицевого нерва. Яка ознака допоможе відрізнити центральне ураження лицевого нерва від периферичного?

- А. Слюзоточивість буде при периферичному паралічі, а при центральному - ні
- В. Порушення смаку буде при центральному паралічі, а при периферичному - ні
- С. Порушення смаку буде при периферичному паралічі, а при центральному - ні
- Д. **Функції м'язів лоба будуть збережені при центральному паралічі, при периферичному - ні**
- Е. Функції м'язів лоба будуть збережені при периферичному паралічі, а при центральному - ні

63. Під час неврологічного огляду чоловіка віком 65 років спостерігається: скутість під час рухів, гіпомімія, ходить човгаючи, наявна поза 'згиначів', тихе монотонне мовлення, ритмічний тремор пальців кистей. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Летаргічний енцефаліт
- В. Енцефаломієліт
- С. Хорея Гентінгтона
- Д. Розсіяний склероз
- Е. **Хвороба Паркінсона**

64. У пацієнта, інфікованого ВІЛ, за останній день виникло 4 генералізованих судомних напади. Після останнього нападу був шпиталізований. Об'єктивно спостерігається: ригідність потиличних м'язів, моторна афазія та правобічний геміпарез. Виконано МРТ головного мозку з контрастним підсиленням, яке виявило кільцеподібні вогнища з перифокальним набряком, які накопичують контраст у вигляді тонкої облямівки. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні результати?

- А. Демієлінізуючого ураження головного мозку

- В. Множинного метастатичного ураження головного мозку
- С. Аутоімунного енцефаліту на тлі СНІДу
- Д. Гострого розсіяного енцефаліту
- Е. **Токсоплазмозу головного мозку**

65. Після падіння з висоти на ліве плече у чоловіка виникла м'язова слабкість у лівій кисті. Об'єктивно спостерігається: ліва кисть звисає, розгинання кисті та пальців різко утруднене, неможливо відвести великий палець, гіпестезія в зоні анатомічної 'табакерки'. Ураження якої структури периферичного відділу нервової системи можна запідозрити у пацієнта?

- А. Плечове сплетення
- В. **Променевий нерв (n. radialis)**
- С. Ліктьовий нерв
- Д. М'язово-шкірний нерв (n. musculocutaneus)
- Е. Серединний нерв (n. medianus)

66. Пацієнт віком 74 років шпиталізований до відділення інтенсивної терапії зі скаргами на слабкість лівих кінцівок, порушення чутливості та порушення ходьби. Об'єктивно спостерігається: лівобічний геміпарез, геміанестезія ліворуч та геміанопсія. У якому судинному басейні виникло пошкодження?

- А. Правій загальній сонній артерії
- В. Лівій середньомозковій артерії
- С. Правій передньомозковій артерії
- Д. **Правій середньомозковій артерії**
- Е. Лівій передньомозковій артерії

67. Під час неврологічного огляду у пацієнта спостерігається порушення поверхневої чутливості. Укажіть, у якій анатомічній структурі розташовані тіла ІІІ нейронів?

- А. Ядрах пучків великого та клинчастого м'язів
- В. Задніх рогах спинного мозку
- С. **Таламусі**
- Д. Передніх рогах спинного мозку
- Е. Спинномозковому ганглію

68. Одинадцятирічну дитину впродовж 3-х днів турбували нежить, кашель, біль у животі, підвищення температури тіла до 38,5°C) До кінця третього дня катаральні явища зменшилися, температура нормалізувалася. На четвертий день раптово виникла слабкість у правій нозі. У неврологічному статусі: відсутні активні рухи в нозі, болючість при пасивних рухах,

гіпотонія, нервові стовбури болючі при пальпації. Колінний та ахіловий рефлекс праворуч відсутні. Із анамнезу відомо, що дитина не вакцинована згідно з календарем щеплень. Який патологічний стан виник у дитини?

- A. Ботулізм
- B. Кліщовий енцефаліт
- C. Поліомієліт, понтинна форма
- D. Енцефаломієліт
- E. **Поліомієліт, спінальна форма**

69. Чоловік віком 48 років скаржиться на погіршення пам'яті, уваги, підвищену роздратованість, нестриманість, сонливість вдень та безсоння вночі. Зі слів дружини, періодично присутні стани дезорієнтації. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цироз печінки. Об'єктивно спостерігається: змінений почерк, атаксія під час ходьби. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Гіпотиреоз
- B. Хронічна ішемічна хвороба головного мозку
- C. Хвороба Альцгеймера
- D. **Хронічна печінкова недостатність**
- E. Хвороба Піквіка

70. Через раптовий розвиток ознак центрального геміпарезу пацієнту було проведено МРТ головного мозку. Обстеження виявлено вогнищевий процес у гемісфері великого мозку з локалізацією в проекції коліна та переднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Укажіть, волокна якого провідного шляху мозку будуть уражені.

- A. Tr. parietooccipitopontinus
- B. Tr. frontothalamicus
- C. Tr. thalamocorticalis
- D. Tr. frontopontinus
- E. **Tr. pyramidalis**

71. Чоловік віком 34 роки скаржиться на двоїння предметів перед очима, порушення координації в кінцівках з лівого боку. У неврологічному статусі праворуч визначаються птоз, мідріаз, розбіжна косоокість, ліворуч - геміатаксія, інтенційний тремор. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Фуа
- B. Бенедикта
- C. Монакова
- D. **Клодта**
- E. Вебера

72. У пацієнта віком 50 років під час огляду спостерігається: слабкість тильного згинання стопи та великого пальця, еверсії стопи. Гіпестезія тильної поверхні стопи та I міжпальцевого проміжку праворуч. Який синдром та ураження якого нерва можна запідозрити у пацієнта?

- A. Синдром верхнього тарзального каналу. Компресійно-ішемічна нейропатія великогомілкового нерва
- B. Синдром Рота-Бернгардта. Компресійно-ішемічна невропатія латерального шкірного нерва стегна
- C. Синдром тарзального каналу. Компресія малогомілкового нерва
- D. Синдром нижнього тарзального каналу. Компресійно-ішемічна нейропатія великогомілкового нерва
- E. **Синдром фібулярного каналу. Компресійно-ішемічна нейропатія малогомілкового нерва**

73. Пацієнт віком 48 років, хворіє на генералізовану форму міастенії 6 років із приводу чого приймає піридостигмін та преднізолон. Впродовж останніх трьох днів стан пацієнта погіршився, слабкість наростала до вечора, з'явилися труднощі з ковтанням і диханням. У зв'язку з погіршенням стану та підозрою на міастенічний криз шпиталізований до відділення інтенсивної терапії. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту?

- A. **Інтубацію трахеї**
- B. Встановити назогастральний зонд
- C. Адреналін внутрішньом'язово
- D. Дексаметазон внутрішньовенно
- E. Прозерин внутрішньом'язово

74. У пацієнта локалізація вогнища ураження - в ділянці нижньої лобової звивини домінантної півкулі. Який патологічний стан виникне у пацієнта?

- A. Сенсорна афазія
- B. Семантична афазія
- C. **Моторна афазія**
- D. Амнестична афазія
- E. Скандоване мовлення

75. Жінку віком 45 років більше 3-х місяців турбують напади нестерпного болю у правій половині обличчя тривалістю 1-2 хв, провокуються дотиком, жуванням. Об'єктивно спостерігається: болючість у точках виходу трійчастого нерва праворуч. Дотик у ділянці крила носа справа

спричиняє черговий напад. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Гайморит
- B. Невралгія язикоглоткового нерва
- C. Артрит нижньощелепного суглоба
- D. Лицева мігрень
- E. **Невралгія трійчастого нерва**

76. У жінки, яка хворіє на постійну форму миготливої аритмії виникло відчуття затерпання лівої руки, її слабкість та асиметрія обличчя, через що її було шпиталізовано через 60 хв після появи симптомів. Об'єктивно спостерігається: лівобічний монопарез руки, асиметрія кутів рота, патологічний рефлекс Бабінського ліворуч. Пацієнтку скеровано на комп'ютерну томографію, яка не підтвердила ознак гострого порушення мозкового кровообігу. Який попередній діагноз встановити цій пацієнтці?

- A. Транзиторна ішемічна атака
- B. Лівобічний брахіоплексит
- C. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- D. Гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом
- E. **Гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом**

77. Через ураження якої анатомічної структури виникає центральний парез мимічних м'язів?

- A. Зовнішнього коліна лицьового нерва
- B. Внутрішнього коліна лицьового нерва
- C. Ядра лицьового нерва
- D. Лицьового нерва до входу у фалопієвий канал
- E. **Кірково-ядерного шляху**

78. Жінка віком 39 років звернулася до клініки зі скаргами на слабкість м'язів обличчя з лівого боку, порушення смаку та надмірно голосний звук у лівому вусі. Патологічної слюзотечі з очей не відзначає. Ураження якої з нижченаведених частин лицьового нерва характерне для цієї симптоматики?

- A. **Між колінчастим ганглієм та стремінцевим нервом**
- B. Між ядром лицьового нерва та колінчастим ганглієм
- C. Між барабанною струною та шилососкоподібним отвором
- D. Ядра лівого лицьового нерва
- E. Між стремінцевим нервом та барабанною струною

79. Чоловік віком 27 років скаржиться на біль у передпліччі, що посилюється при пронації та згинанні ліктьового суглоба, втрату чутливості у всій долоні, слабкість згинання великого пальця і відведення великого пальця кисті ліворуч. Позитивний тест Тінеля над круглим пронатором. Ураження якого нерва спостерігається у пацієнта?

- A. Ліктьового
- B. Променевого
- C. Плечового сплетення
- D. Ліктьового та променевого
- E. **Серединного**

80. Чоловік віком 45 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, мимовільні рухи та порушення координації в кінцівках ліворуч. У неврологічному статусі праворуч визначаються птоз, мідріаз, розбіжна косоокість, ліворуч - хореоатетоз, інтенційний тремор. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Вебера
- B. **Бенедикта**
- C. Фуа
- D. Монакова
- E. Клодта

81. У пацієнта віком 34 роки невралгія 1-ї гілки трійчастого нерва праворуч. Який препарат є першою лінією терапії цього захворювання?

- A. **Карбамазепін**
- B. Німесулід
- C. Неостигмін
- D. Новокаїн
- E. Пентоксифілін

82. У дівчинки віком 19 років після перенесеної вірусної інфекції протягом трьох днів поступово виникли скарги на труднощі при ходьбі, порушення координації, періодичні падіння. Під час неврологічного огляду виявлено зниження сили з нижніх кінцівок до 4 балів, більше проксимально, сухожилкові рефлeksi нижніх кінцівок відсутні, верхніх кінцівок симетрично знижені. Виявлено ознаки атаксії, у позі Ромберга - падіння. При обстеженні черепних нервів - двобічна слабкість m. orbicularis oris, неможливість відведення очних яблук у крайні бокові положення. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. **Гостра запальна полінейропатія**

- B.** Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія
- C.** Гострий інфекційний поліміозит
- D.** Хворобу мотонейрону
- E.** Мультифокальна моторна полінейропатія

83. Жінка віком 57 років скаржиться на раптове погіршення зору. Під час неврологічного огляду виявлено: лівобічну верхньоквадрантну геміанопсію. У якій анатомічній структурі найімовірніше локалізується вогнище ураження?

- A.** Верхній порції зорової кори праворуч
- B.** Лобній частці ліворуч
- C.** Нижній частині клиновидної борозни з правого боку
- D.** Тім'яній частці праворуч
- E.** Верхній частині клиновидної борозни праворуч

84. У чоловіка віком 34 роки скаржиться на судоми в ногах, болючі спазми м'язів кистей, посіпування повік. Із анамнезу відомо, що у пацієнта діагностовано: гіпарпаратиреоз. Під час неврологічного огляду спостерігається: позитивні симптоми Хвостека та Труссо. Чим зумовлені неврологічні порушення?

- A.** Порушеннями вуглеводного обміну
- B.** Дефіцитом факторів протромбінового комплексу
- C.** Порушеннями кальцієво-фосфорного обміну
- D.** Дефіцитом вітамінів групи B
- E.** Розладами водно-електролітного балансу

85. Жінка віком 65 років, доставлена бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу. За результатами комп'ютерної томографії виявлено інфаркт мозку внаслідок тромбозу в медіальних відділах лобової частки ліворуч. Який судинний басейн уражено у пацієнтки?

- A.** Хребетна артерія ліворуч
- B.** Задня сполучна артерія
- C.** Передня мозкова артерія ліворуч
- D.** Задня мозкова артерія ліворуч
- E.** Середня мозкова артерія ліворуч

86. Жінка віком 35 років доставлена до приймально-діагностичного відділення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги. З анамнезу відомо, що захворіла гостро близько 1 год тому, коли після

психо-емоційного стресу раптово виник інтенсивний головний біль, блювота, порушення мовлення, слабкість у кінцівках праворуч, після чого втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, АТ - 220/120 мм рт. ст., проводиться штучна вентиляція легень. Неврологічний статус: кома, білатеральна розбіжна косоокість за горизонталлю, тетраплегія, у відповідь на больові подразники явища децеребраційної ригідності в кінцівках ліворуч. Якому значенню сумарного бала за шкалою ком Глазго відповідають вищезазначені порушення?

- A.** 4
- B.** 5
- C.** 6
- D.** 3
- E.** 7

87. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на виражений біль у поперековому відділі хребта. Із анамнезу відомо: екстирпація матки через рак тіла матки роки тому. Встановлено діагноз: гостра радикулопатія L5 корінця з вираженим больовим та м'язово-тонічним синдромами. Легкий лівобічний нижній переважно дистальний периферичний монопарез. Лівобічна гіпестезія за дерматомом L5. Які дообстеження та з якою метою необхідно виконати цій пацієнтці?

- A.** УЗД органів малого тазу через наявність у пацієнтки 'червоних прапорців': вік, онкоанамнез
- B.** Загальний аналіз крові, та онкологічні біомаркери через наявність у пацієнтки 'червоних прапорців': вік, онкоанамнез
- C.** КТ попереково-крижового відділу хребта через наявність у пацієнтки 'червоних прапорців': вік, онкоанамнез
- D.** МРТ попереково-крижового відділу хребта через наявність у пацієнтки 'червоних прапорців': вік, онкоанамнез
- E.** МР-спектроскопію через наявність у пацієнтки 'червоних прапорців': вік, онкоанамнез

88. Унаслідок ураження якої анатомічної структури виникає амавроз?

- A.** Бічного колінчастого тіла
- B.** Нюхової цибулини
- C.** Зорового нерва
- D.** Нюхового шляху

Е. Зорового шляху

89. У неврологічному статусі пацієнта віком 54 роки виявлено синдром Горнера. Які симптоми спостерігаються у пацієнта?

- А. Мідріаз, птоз, енофтальм
- В. Птоз, міоз, диплопія
- С. Міоз, птоз, екзофтальм
- Д. Міоз, птоз, енофтальм
- Е. Мідріаз, птоз, лагофтальм

90. Чоловік віком 31 рік скаржиться на головний біль, блювоту. Із анамнезу відомо, що в пацієнта діагностовано хронічний отит. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,9°C, АТ - 140/85 мм рт. ст., ЧСС - 96/хв, птоз зліва, анізокорія (S>D), розбіжна косоокість за рахунок лівого ока, загальна гіперестезія, позитивний симптом Керніга, ригідність м'язів потилиці +5 см. У результаті лабораторного дослідження ліквору: колір мутний, тиск підвищений, цитоз - 500, нейтрофілів - 85%, білок - 2,5 г/л. Установіть попередній діагноз.

- А. Геморагічний паренхіматозний крововилив
- В. Субарахноїдальний крововилив
- С. Конвексимальний арахноїдит
- Д. Енцефаліт у стовбурі мозку
- Е. Вторинний гнійний менінгіт

91. Пацієнт не може назвати добре знайомі предмети (іменники). Для якого типу афазії це характерно?

- А. Сенсорної
- В. Апраксії
- С. Моторної
- Д. Амнестичної
- Е. Семантичної

92. Чоловік віком 41 рік доставлений до лікарні після аварії на виробництві. Скраги на порушення рухів у кінцівках. Об'єктивно спостерігається: спастичний тетрапарез, втрата всіх видів чутливості з рівня С2 за провідниковим типом, центральна затримка сечовипускання, бульбарні розлади. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Перелом основи черепа
- В. Субарахноїдальний крововилив
- С. Здавнення спинного мозку
- Д. Дифузне аксональне ушкодження
- Е. Струс мозку

93. Чоловік віком 55 років із встановленим діагнозом: міастенія, очна форма анти-МСК позитивна, захворів на позагоспітальну пневмонію. Призначено антибіотик - ципрофлоксацин. Раптово у пацієнта розвинулася слабкість м'язів, утруднене дихання, пітливість, тахікардія, дисфагія, гіперсалівація. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Міастенічний криз
- В. Менінгоенцефаліт
- С. Респіраторний дистрес синдром
- Д. Синдром Гієсна-Барре
- Е. Синдром Ландрі

94. У чоловіка віком 28 років, який отримав травму з переломом ключиці, з'явився в'ялий атрофічний парез правої руки з порушенням усіх видів чутливості в ній. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Шийно-грудний радикуліт
- В. Синдром кубітального каналу
- С. Цервікоторакалгія
- Д. Поліневропатія
- Е. Правобічний плечовий плексит

95. У чоловіка віком 76 років в анамнезі гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом у середній мозковій артерії. Об'єктивно спостерігається: згладженість носогубної складки, опущеність кута рота та асиметрія при спробі посміхнутися. Ураження якого з нижченаведених провідних шляхів спричинив неврологічний дефіцит?

- А. Бічного кірково-м'язового
- В. Текто-спінального
- С. Руброспінального
- Д. Кірково-ядерного
- Е. Переднього кірково-м'язового

96. Жінка віком 30 років шпиталізована до неврологічного відділення зі скаргами на слабкість у ногах, відчуття оніміння стоп, хитку ходьбу. Неврологічне обстеження виявило нижній парапарез зі зниженням больової та вібраційної чутливості дистально в ногах, збереженими функціями тазових органів, рефлeksi з нижніх кінцівок симетрично підвищені, патологічних рефлексів не виявлено. Із анамнезу відомо, що протягом 7-ми років хворіє на В₁₂-дефіцитну анемію. Який патологічний стан можна запідозрити у пацієнтки?

- А. Фунікулярний мієлоз
- В. Сенсорну полінейропатію

- С. Гостре порушення спинномозкового кровообігу
- Д. Хворобу мотонейрона
- Е. Сирингомієлію

97. Яка з нижченаведених пухлин нервової системи може розвиватися зі структур периферичних нервів?

- А. Астцитома
- В. Меланома
- С. Менінгіома
- Д. Гліома
- Е. Шванома

98. У чоловіка віком 43 роки виявлено правобічний прозопарез зі слезотечею. Із анамнезу відомо, що місяць тому пацієнт звернувся до дерматолога з приводу еритематозних кільцеподібних плям на шкірі стегна. Установіть попередній діагноз пацієнту.

- А. Понтинна форма поліомієліту
- В. Параліч Белла
- С. Невринома мосто-мозочкового кута
- Д. Нейробореліоз
- Е. Ішемічний інсульт в судинах ВББ

99. За допомогою якої класифікації розрізняють 5 патогенетичних варіантів ішемічного інсульту?

- А. МОЗОК-ЧАС
- В. TOAST
- С. NIHSS
- Д. ASPECTS
- Е. АНА/АSА

100. Чоловік віком 37 років скаржиться на інтенсивний головний біль, що виник раптово, супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням. Об'єктивно спостерігається: АТ - 210/120 мм рт. ст., болючість тригемінальних та окципітальних точок при пальпації, ригідність м'язів потилиці 4 см, позитивний симптом Керніга. Який метод обстеження показаний для верифікації діагнозу?

- А. КТ головного мозку
- В. ЕЕГ
- С. Краніографія
- Д. УЗД вен голови та шиї
- Е. Люмбальна пункція

101. Передній та латеральний спіноталамічні тракти проводять імпульси від рецепторів шкіри, які сприймають тактильну, температурну й больову

чутливості всіх частин тіла, окрім обличчя. Укажіть 3 нейрони цих трактів.

- А. I нейрон - зубчасте ядро, II нейрон - черв'як мозочка, III нейрон - нижні червоні ядра
- В. I нейрон - спінальний ганглії, II нейрон - задній ріг спинного мозку (substantia gelatinosa), III нейрон-Таламус (вентральне постеролатеральне ядро)
- С. I нейрон - моторна кора, II нейрон - середній мозок, III нейрон - ядро трійчастого нерву
- Д. I нейрон - покривка стовбуру мозку, II нейрон - черв'як мозочка, III нейрон - нижні холмики corpora quadrigemina
- Е. I нейрон - спінальний ганглії, II нейрон - nucleus cuneatus/gracilis (довгастий мозок), III нейрон - Таламус (вентральне постеролатеральне ядро)

102. Чоловік віком 50 років доставлений до приймально-діагностичного відділення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги з робочого місця протягом 1 год після початку захворювання. З анамнезу відомо, що хворіє на фібриляцію передсердь. Захворів гостро, відчув головний біль, нудоту, слабкість у лівих кінцівках. АТ- 160/100 мм рт. ст., ЧСС - 76/хв. В неврологічному статусі: лівобічний геміпарез до 4 балів з незначним зниженням чутливості. На КТ - вогнищ не виявлено. Який препарат доцільно застосувати пацієнту?

- А. Церебралізін
- В. Діазепам
- С. Цитіколін
- Д. Фраксіпарин
- Е. Тканинний активатор плазміногену

103. У молодого чоловіка під час фізичного навантаження у спекотний день раптово виник сильний головний біль. Короткочасно втрачав свідомість, було блювання. Об'єктивно спостерігається: ригідність потиличних м'язів, виличний симптом Бехтерева. Установіть попередній діагноз пацієнту?

- А. Субарахноїдальний крововилив
- В. Колапс
- С. Черепно-мозкова травма
- Д. Хвороба Мен'єра
- Е. Інфаркт міокарда

104. У чоловіка віком 62 років під час неврологічного обстеження спостерігається: гіпертермія, розбіжна

косоокість, вегетативні розлади ('сальне обличчя', загальний гіпергідроз). Пацієнт сонний, під час спроби його розбудити скаржиться на двоїння в очах. Який патологічний стан має запідозрити лікар?

- A. Паненцефаліт
- B. Арахноїдит
- C. Гострий енцефаломієліт
- D. Розсіяний склероз
- E. Епідемічний енцефаліт

105. Жінка віком 26 років скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль у правій половині голови, який іррадіює в око, посилюється від голосних звуків, світла. Подібні напади відбуваються вже протягом 6-ти років. Перед нападом відчуває посилену чутливість до запахів. Установіть попередній діагноз.

- A. Кластерний головний біль
- B. Шийна мігрень
- C. Епізодичний головний біль напруги
- D. Синдром шийних симпатичних вузлів
- E. Мігрень із аураю

106. На прийом до лікаря-невролога звернувся чоловік із періодичним болем у нижній частині спини. Після проведення МРТ поперекового відділу хребта виявлено початкові дегенеративні зміни міжхребцевих дисків. Який ефективний метод профілактики прогресування дегенеративних змін необхідно призначити пацієнту?

- A. Фітотерапію
- B. Бальнеологічні процедури
- C. Регулярний прийом хондропротекторів
- D. Фізичну терапію та реабілітацію
- E. Апаратну фізіотерапію

107. Жінка віком 50 років із діагнозом: бактеріальний менінгіт протягом 10-ти днів приймала антибіотик. На тлі лікування стан покращився, зменшився загально мозковий, загальноінфекційний та менінгеальний синдроми, 4 дні температура тіла коливається в межах 36,4-36,7°C. За яких умов можна зупинити введення антибіотика?

- A. Плеоцитоз не більше 120 клітин в 1 мл, з них 75% - нейтрофіли
- B. Ліквор безбарвний, прозорий, під нормальним тиском, цитоз 110 клітин, з них 65% - нейтрофіли
- C. Відсутність лейкоцитозу із зсувом лейкоцитарної форми вліво

D. Плеоцитоз не більше 150 клітин в 1 мл, з них 75% - лімфоцити

E. Плеоцитоз не більше 100 клітин в 1 мл, з них 75% - лімфоцити

108. Жінці віком 54 роки встановлено діагноз: пізня дистальна міопатія. Об'єктивно спостерігається: в'ялий симетричний тетрапарез, виражений до легкого у верхніх та помірного у нижніх кінцівках. Який метод інструментального дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- A. УЗД м'язів верхніх та нижніх кінцівок
- B. ЕНМГ
- C. МРТ усіх відділів хребта
- D. МРТ поперекового відділу хребта
- E. КТ поперекового відділу хребта

109. Унаслідок падіння з висоти четвертого поверху чоловік отримав перелом хребта із забоем грудного відділу спинного мозку. Об'єктивно спостерігається: нижня параплегія, тотальна анестезія з рівня пупкової лінії. Який вегетативний розлад слід очікувати у пацієнта?

- A. Гіпертермію центрального походження
- B. Міоз, анізокорію
- C. Гіпергідроз
- D. Періодичне нетримання сечі
- E. Гостру затримку сечі

110. Укажіть найчастішу причину нетравматичного субарахноїдального крововиливу?

- A. Розрив менінгеальних артерій
- B. Амілоїдна ангіопатія
- C. Апоплексія гіпофізу
- D. Гемангіома
- E. Розрив артеріальної аневризми

111. На амбулаторний прийом звернулася жінка віком 45 років зі скаргами на головний біль, підвищення температури тіла до 38°C протягом останніх 3-х днів, дискомфорт при рухах шиєю, двоїння в очах. Об'єктивно спостерігається: збільшення лімфовузлів у аксіялярній ділянці, плямисто-папульозна висипка на шкірі, ригідність потиличних м'язів, на руках сліди від кігтів. Жінка повідомила, що кілька тижнів тому підбрала кішку на вулиці, яка активно дряпається. Яке інфекційне захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

- A. Лейшманіоз
- B. Балантидіаз

- С. Лямбліюз
- Д. Трихінельоз
- Е. Токсоплазмоз

112. Чоловік віком 62 роки скаржиться на прогресуючу слабкість, незграбність рухів та зниження м'язової сили в руках (більше в лівій), яке помітив приблизно рік тому, посикування у м'язах рук та згодом на тулубі, швидко стомлювався на роботі. Через декілька місяців відзначив постійні зміни настрою, надмірну плаксивість. Через 6 місяців з'являлися слабкість в ногах, задишка при підйомі сходами, дисфагія та надмірне слиновиділення вночі. Схуд на 7-10 кг. У неврологічному статусі: глотковий рефлекс знижений з обох боків. М'язова сила у лівій руці - 3/5, у правій руці та нижніх кінцівках - 4/5. СПР S>D) Рефлекси орального автоматизму: Аствацатурова +. Патологічні кистьові рефлекси: Жуковського + ліворуч. Патологічні стопні рефлекси: Бабінського + праворуч. Дифузні аміотрофії та часті фасцикуляції м'язів плечей, передпліч та тулуба. Чутливість інтактна, функцію тазових органів контролює. При проведенні стимуляційної ЕНМГ виявлено гігантські F хвилі. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Міастенія гравіс (серопозитивна anti-AChR), генералізована прогресуючий перебіг
- В. Мультифокальна моторна невропатія з блоками проведення, анти-GM1-позитивна
- С. Церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія із субкортикальними інфарктами
- Д. Бічний аміотрофічний склероз. Грудно-поперековий початок, прогресуючий перебіг
- Е. Розсіяний склероз, ремітуючо-рецидивуючий перебіг високоактивний з прогресуванням

113. Чоловік віком 48 років скаржиться на двоїння предметів перед очима та слабкість у кінцівках ліворуч. У неврологічному статусі праворуч визначаються птоз, мідріаз, розбіжна косокість, ліворуч - геміпарез із підвищеним м'язовим тонусом, позитивний симптом Бабінського. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- А. Бенедикта
- В. Вебера
- С. Фуа

- Д. Клодта
- Е. Монакова

114. У чоловіка віком 28 років без втрати свідомості спостерігаються напади посикування правої кисті, що поширюються на праву половину обличчя і тривають декілька хвилин. Після нападу відзначається нетривала слабкість руки. Вкажіть тип нападу.

- А. Джексонівська епілепсія
- В. Істерія
- С. Генералізований тоніко-клонічний напад
- Д. Міоклонія
- Е. Кожевніківська епілепсія

115. Пацієнту після введення неостигміну метилсульфату зменшується стомлюваність м'язів, підвищується фізичне навантаження. Який патологічний стан може запідозрити лікар?

- А. Міастенію
- В. Міотонію
- С. Аміотрофію
- Д. Міопатію
- Е. Нейропатію

116. Жінка віком 27 років впродовж останніх 6-ти місяців відчувала слабкість у ногах, що поступово наростала. Близько місяця тому на тлі психоемоційного перенавантаження з'явилась хиткість при ходьбі, часте сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: центральний нижній парапарез, батігіпестезія в пальцях стоп, імперативні поклики до сечопуску. Яке обстеження необхідно призначити пацієнтці з метою верифікації діагнозу?

- А. Електроенцефалографія
- В. КТ головного мозку (нативне)
- С. Електронейроміографія
- Д. МРТ головного мозку з контрастним підсиленням
- Е. КТ головного мозку з контрастним підсиленням

117. Укажіть, як змінюється тонус м'язів пацієнта у позі Верніке-Манна?

- А. Спастичне підвищення м'язового тону у паретичних кінцівках - згиначах руки та розгиначах ноги
- В. Спастичне підвищення м'язового тону у згиначах руки та ноги з протилежного від вогнища боку

- С. Підвищення пластичного тону у м'язах шиї
- Д. Підвищення м'язового тону у всіх кінцівках за пластичним типом
- Е. М'язова гіпотонія в паретичних кінцівках

118. У пацієнта під час неврологічного огляду лікар запідозрив атаксію Фрідрайха. Які скелетні аномалії характерні для цієї патології?

- А. Арахнодактилія
- В. Ущелина верхньої щелепи
- С. **Порожниста стопа з високим підйомом**
- Д. Доліхоцефалія
- Е. Брахіцефалія і сплюснення обличчя

119. Чоловік віком 36 років, який працює будівельником, після отриманої травми плеча скаржиться на обмеження активних рухів у плечовому суглобі, неможливість підняти руку до горизонтального рівня та зігнути руку в лікті. Об'єктивно спостерігається: відсутність біцепс рефлексу, карпорадіального рефлексу, болючість при пальпації у надключичній ямці, гіпестезію по зовнішній поверхні правого плеча. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Синдром замороженого плеча
- В. Тендініт ротаторної манжети плеча
- С. **Брахіоплексит Дюшена-Ерба**
- Д. Мультифокальна моторна полінейропатія
- Е. Компресійна мононевропатія ліктьового нерва

120. Жінка віком 26 років доставлена до приймально-діагностичного відділення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги. Об'єктивно спостерігається: брадикардія, фасцикулярні посмикування м'язів, судоми, підвищене потовиділення та слиновиділення. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на міастенію. Який патологічний стан має запідозрити лікар?

- А. **Холінергічний криз**
- В. Епілептичний напад
- С. Ішемічний інсульт у стовбурі мозку
- Д. Синдром вегетативної дисфункції
- Е. Міастенічний криз

121. Під час неврологічного огляду жінки віком 46 років спостерігається: при спробі співдружного руху очей вправо у горизонтальній площині ліве око поступово відстає і не проходить далі

середньої лінії. Одночасно в правому оці виникає монокулярний горизонтальний ністагм. Встановлено діагноз: між'ядерна офтальмоплегія. Укажіть, яка структура головного мозку уражена в цієї пацієнтки.

- А. Окоруховий нерв
- В. Тім'яна доля
- С. Ядра черепних нервів
- Д. Ядро блокового нерва
- Е. **Медіальний поздовжній пучок**

122. У жінки віком 20 років під час офтальмологічного огляду виявлені кільця Кайзера-Флейшера, що обводять рогівку ока. Яке лабораторне обстеження необхідно провести пацієнту для підтвердження спадкового захворювання?

- А. Визначення рівня калію в сироватці крові
- В. Визначення рівня цистацину С
- С. **Визначення рівня міді й церулоплазміна в сироватці крові**
- Д. Визначення наявності олігоклональних IgG в лікворі
- Е. Визначення рівня креатинінфосфокінази в сироватці крові

123. Пацієнт віком 37 років протягом 5-ти років хворіє на розсіяний склероз. За останній тиждень помітив появу похитування при ходьбі, інтенційного тремору та промахування при виконанні пальце-носової та колінно-п'яткової проб, скандованого мовлення. Яка структура нервової системи вражена?

- А. **Хробак і півкулі мозочка**
- В. Верхні ніжки мозочка
- С. Міст
- Д. Червоне ядро
- Е. Передні відділи лобної частки

124. Яка пухлина ЦНС формується з епендимальних тканин шлуночкової системи мозку та центрального каналу спинного мозку?

- А. **Епендемома**
- В. Плазмоцитома
- С. Хондробластома
- Д. Шванома
- Е. Менінгеома

125. Чоловік віком 45 років скаржиться на напади болю в корені язика під час вживання холодної та гарячої їжі. Тривалість болю - до 10 хв. Біль супроводжується сухістю в роті, а після нападу виділяється багато слини.

Об'єктивно спостерігається: тригерні ділянки в зоні кореня язика. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Невралгія язикоглоткового нерва
- B. Невралгія відієвого нерва
- C. Гангліоніт шийних симпатичних нервів
- D. Невралгія трійчастого нерва
- E. Гангліоніт крилопіднебінного нерва

126. Пацієнт віком 36 років звернувся зі скаргами на постійні мимовільні рухи в кінцівках, тулубі, посмикування обличчя, висовування язика, ці рухи хаотичні, він не може їх контролювати, вони зникають тільки під час сну. Порушення мовлення, вона стала тихою та нечіткою. Порушення пам'яті, роздратованість. В анамнезі встановлено: батько мав подібні симптоми та помер у віці 54 роки. У неврологічному статусі пацієнта: виражені мимовільні рухи у всіх частинах тіла, проте більше виражені у верхньому плечовому поясі, дизартрія. СРР та чутливість у межах норми. МРТ головного мозку - зменшення розмірів голівок хвостатих ядер двобічно, дифузна атрофія речовини головного мозку. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A. Хвороба Гентінгтона
- B. Хвороба Галлервордена-Шпатца
- C. Хвороба Вільсона
- D. Хвороба Паркінсона
- E. Хорея Сиденхема

127. Пацієнт віком 24 роки звернувся по допомогу до відділення невідкладної допомоги після того, як отримав різану рану задньої поверхні лівої гомілки. Скаржиться на неможливість підшовного згинання стопи, а також оніміння підшви. Ураження якого периферичного нерва відбулося у пацієнта?

- A. Великогомількового нерва
- B. Бічного шкірного нерва стегна
- C. Стегнового нерва
- D. Малогомількового нерва
- E. Сідничного нерва

128. Чоловіка віком 40 років турбує відчуття 'внутрішнього перенапруження', неспокою, тривожності. Дружина помітила неспровоковані зміни в поведінці чоловіка, вказує на його немотивовану ейфоричність, виражені емоційні реакції, ажитованість. Результатом якої дії на відповідну структуру головного мозку є така симптоматика?

- A. Ірритації гіпоталамічної ділянки

- B. Пригнічення лобової частки
- C. Пригнічення лімбічної системи
- D. Ірритації ретикулярної формації
- E. Ірритації лімбічної системи

129. Дівчина віком 23 роки скаржиться на різкий головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, блювання. Об'єктивно спостерігається: загальмована, позитивні менингеальні симптоми, ознаки ураження III та IV пар черепних нервів. Результати аналізу ліквору: мутний, тиск підвищений, цитоз - 20000 (переважно нейтрофіли), білок - 3 г/л. Яке захворювання у пацієнтки?

- A. Туберкульозний менингіт
- B. Субарахноїдальний крововилив
- C. Пухлина головного мозку
- D. Енцефаліт
- E. Менингококковий менингіт

130. До приймального відділення доставлена жінка віком 24 роки, у якій після стресу виникли різкий головний біль, нудота, блювота, запаморочення. Через 15 хв розвинулося порушення свідомості. Об'єктивно спостерігається: кома, клонічні судоми в кінцівках, позитивний менингеальний синдром, симптом Бабінського позитивний з обох боків, АТ - 180/100 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- B. Епілептичний статус
- C. Субарахноїдальний крововилив
- D. Менингіт
- E. Геморагічний паренхіматозний крововилив

131. У пацієнта віком 50 років протягом останніх шести місяців поступово виникли слабкість лівої руки, її атрофія та періодичні посмикування м'язів у плечі. Лікар запідозрив хворобу мотонейрона. Яке з нижченаведених обстежень доцільно провести для підтвердження діагнозу?

- A. Стимуляційну нейроміографію
- B. Магнітно-резонансну томографію шийного відділу хребта
- C. Голкову нейроміографію
- D. Магнітно-резонансну томографію головного мозку
- E. Комп'ютерну томографію головного мозку

132. У пацієнта запідозрено закриту черепно-мозкову травму. Укажіть основну ознаку струсу головного мозку.

- A. Субарахноїдальний крововилив
- B. Ретроградна амнезія
- C. Геміпарез
- D. Утворення каротидно-кавернозної нориці
- E. Парез погляду вгору

133. Який симптом може виникнути у пацієнта з ураженням задньої мозкової артерії ліворуч?

- A. Правобічна гомонімна геміанопсія
- B. Правобічний гемінеглект
- C. Лівобічний гемінеглект
- D. Афазія Верніке
- E. Лівобічна гомонімна геміанопсія

134. У пацієнта з діагнозом: В₁₂-дефіцитна анемія з'явилося відчуття повзання 'мурах', слабкість у ногах, похитування при ходьбі. Під час неврологічного огляду спостерігається: помірна атаксія, нижній дистальний парепарез із порушенням чутливості. Яке захворювання має запідозрити лікар?

- A. Поліневропатія
- B. Дисциркуляторна енцефалопатія
- C. Мієлопатія
- D. Невроз
- E. Токсична енцефалопатія

135. Жінку віком 57 років впродовж 2-3 місяців турбує пекучий біль у стопах. З анамнезу відомо, що 7 років хворіє на цукровий діабет типу 2-го, цукрознижуючу терапію приймає нерегулярно. У неврологічному статусі виявлено схуднення м'язів гомілок, сухість та блідість шкіри, рефлeksi на ногах торпідні, чутливість знижена за типом 'шкарпеток'. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Ендартеріт нижніх кінцівок
- B. Атеросклероз нижніх кінцівок
- C. Невропатія сідничного нерва
- D. Невропатія малогомілкових нервів
- E. Діабетична полінейропатія

136. Чоловік віком 45 років працює шахтарем та звернувся до поліклініки зі скаргами на втомлюваність, загальну скутість, тремор рук у стані спокою, сповільнену ходьбу, часті падіння. Під час огляду спостерігається: олігобрадикінезія, статичний тремор пальців рук, м'язевий тонус в кінцівках підвищений за

спастичним типом. Про екзогенну інтоксикацію пацієнта якою речовиною свідчать такі симптоми?

- A. Беладонною
- B. Миш'яком
- C. Свинцем
- D. Барбітуратами
- E. Марганцем

137. У пацієнта віком 45 років із аневризмою мозкової судини під час фізичного напруження раптово виникли сильний головний біль, нетривала втрата свідомості, блювання. Пацієнт збуджений, пульс - 62/хв, ритмічний, АТ - 140/90 мм рт. ст., температура тіла - 37,5°C. Під час неврологічного огляду спостерігається: ригідність м'язів у потилиці, симптом Керніга. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Який попередній діагноз?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Ішемічний інсульт
- C. Субарахноїдальний крововилив
- D. Крововилив у півкулю мозку
- E. Менінгіт

138. Пацієнтка віком 45 років шпиталізована до інфекційного відділення зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,5°C, виражену загальну слабкість, сильний головний біль, на фоні яких виникає блювання без полегшення. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, легке оглушення, на запитання відповідає із затримкою. Блідість шкірних покривів, гарячі на дотик, ригідність потиличних м'язів 4 см, симптом Керніга 60° двобічно. У загальному аналізі крові: лейкоцитоз - $19,0 \cdot 10^9/\text{л}$, зсув лейкоцитарної формули вліво. Яке обстеження необхідно призначити для верифікації діагнозу?

- A. Спинномозкова пункція
- B. МРТ головного мозку
- C. Біохімічний аналіз крові
- D. Імунологічне обстеження
- E. Рентгенографія органів грудної клітки

139. Чоловік віком 67 років раптово відчув слабкість у правих кінцівках, порушилося мовлення. Об'єктивно спостерігається: моторна афазія, правобічний геміпарез з об'ємом рухів до 4 балів. АТ - 130/80 мм рт. ст., ЧСС - 70/хв. Через 2 год неврологічна симптоматика регресувала. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- A. Інфаркт мозку в правій півкулі головного мозку
- B. **Транзиторна ішемічна атака**
- C. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- D. Інфаркт мозку в лівій півкулі головного мозку
- E. Субарахноїдальний крововилив

140. Чоловік віком 47 років скаржиться на частий головний біль, який турбує більше року, стан не покращується після прийому НПЗЗ. Упродовж останнього місяця з'явилися періодичні мимовільні посмикування великого пальця лівої руки, які через пів хвилини розповсюджуються в руку, плече та ліву половину обличчя. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. **Пухлина правої прецентральної звивини**
- B. Абузусний головний біль
- C. -
- D. Мігренозний головний біль
- E. Цервікокраніалгія

141. У пацієнта після видалення пухлини спинного мозку через ураження шийного відділу виник синдром Горнера, що класично характеризується одностороннім птозом, міозом та енофтальмом. Які ще прояви можуть виникати в структурі цього ураження?

- A. **Ангідроз половини обличчя**
- B. Ринорея
- C. Диплопія при погляді вниз
- D. Парез акомодатції
- E. Ністагм

142. У чоловіка віком 36 років упродовж пів року спостерігалась погіршення емоційного стану, поступове порушення пам'яті. У результатах дослідження виявлено: метаболічний ацидоз, збільшення та ущільнення печінки, збільшення селезінки. У неврологічному статусі: помірна деменція, екстрапірамідний тремор рук, легка олігобрадикінезія, симптом Марі (+), Нойка-Ганева (+) двобічно, ахейрокінез. Проведене МРТ-обстеження головного мозку виявило атрофію подушки та блідої кулі. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Постенцефалітний паркінсонізм
- B. Гіперпаратиреоз
- C. **Гепатолентикулярна дегенерація**
- D. Акінетичний мутизм
- E. Хвороба Паркінсона

143. Жінка віком 35 років шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з колото-різаною раною нижньої частини ший. У неврологічному статусі - лівостороння геміплегія. Сухожилкові рефлекси ліворуч: з двуголового м'яза 1+, колінні та ахіллові 3+, праворуч 2+ з верхніх та нижніх кінцівок. Провідникова гіпестезія з рівня T1 праворуч. Вібраційна чутливість при дослідженні камертоном Ріделя-Сейффера: на верхніх кінцівках та нижніх кінцівках праворуч 6,0 б, ліворуч 2,0 б. Який із синдромів розвинувся у жінки? Які шляхи залучені в розвиток цього синдрому?

- A. Синдром задніх стовпів спинного мозку. Кірково-спинномозковий шлях
- B. Синдром центрального ураження спинного мозку. Латеральний та передній корково-спинномозкові шляхи
- C. Синдром ураження задніх стовпів. Кортикоспінальний, латеральний спиноталамічний, шляхи Голля та Бурдаха в задніх канатиках
- D. **Синдром Броун-Секара (гемікорд синдром). Кортикоспінальний, латеральний спиноталамічний, шляхи Голля та Бурдаха**
- E. Синдром ураження передніх рогів спинного мозку. Латеральний та передній корково-спинномозкові шляхи

144. Чоловік віком 39 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, асиметрію мимічної мускулатури ліворуч, слабкість та оніміння в кінцівках з лівого боку. У неврологічному статусі ліворуч визначаються збіжна косоокість, периферичний прозомонопарез, праворуч - геміпарез, гемігіпестезія. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Раймона-Сестана
- B. **Фовілла**
- C. Бріссо-Сікара
- D. Мійяра-Гублера
- E. Гасперіні

145. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на виражений біль у поперековому відділі хребта з іррадіацією по задньолатеральній поверхні стегна. У неврологічному статусі: м'язова сила на верхніх кінцівках - 5/5 без різниці сторін, на нижніх кінцівках праворуч - 5/5, ліворуч - 4/5. Сухожилльні та періостальні рефлекси на верхніх кінцівках жваві, D=S, із нижніх кінцівок колінні D=S, ахілловий рефлекс ліворуч не викликається. Симптом Ласега позитивний ліворуч. Гіпестезія

ліворуч по задній поверхні стегна, по задній та передньолатеральній частині гомілки та у мізинці, праворуч не порушена. Функцію тазових органів контролює. Визначте уражений нервовий корінець.

- A. Th12
- B. L3-L4
- C. **L5**
- D. C6
- E. C7

146. Чоловік віком 68 років скаржиться на порушення мовлення та слабкість у кінцівках праворуч, що виникли раптово 3 год тому. У неврологічному статусі визначаються моторна афазія легкого ступеня, помірно виражений дисоційований правобічний геміпарез (брахіофаціальний тип). За даними комп'ютерної томографії головного мозку виявлено гіподенсивний осередок у кортикально-субкортикальних структурах лобової частки ліворуч. Які зміни біоелектричної активності головного мозку за даними електроенцефалографічного дослідження є найбільш очікуваними у цьому разі?

- A. **Фокальні повільні хвилі**
- B. Фокальні гострі хвилі
- C. Фокальні спайки
- D. Генералізоване уповільнення ритмів
- E. Фокальні комплекси 'гостра хвиля - повільна хвиля'

147. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на неможливість розігнути ногу в колінному суглобі. Під час неврологічного огляду виявлено порушення чутливості на внутрішній поверхні гомілки та передній поверхні стегна, м'язи стегна гіпотрофічні. Симптом Вассермана позитивний. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. **Невропатія стегнового нерва**
- B. Плексопатія попереково-крижового сплетення
- C. Артроз колінного суглоба
- D. Радікулопатія корінців L3-L4
- E. Міастенічний синдром

148. У пацієнта встановлений діагноз: розсіяний склероз, первинно-проградієнтний перебіг. Об'єктивно спостерігається: помірний тетрапарез, гіпестезія та гіпалгезія лівої верхньої кінцівки з дистальним превалюванням. За допомогою якої шкали можна оцінити

ступінь інвалідизації та прогресування захворювання?

- A. FOUR
- B. BARHTEL
- C. El Escorial
- D. NIHSS
- E. **EDSS**

149. У військового після осколкового поранення в ділянці зовнішньої поверхні правого колінного суглоба нижче голівки малогомілкової кістки виникла слабкість у стопі. Скаржиться на утруднену ходьбу, неможливість стояти на правій п'ятці. Під час огляду спостерігається: права стопа звисає, її розгинання неможливе, при ходьбі - степаж з правого боку. Виявлена гіпалгезія по латеральній поверхні гомілки і стопи праворуч. Укажіть, який нерв пошкоджено.

- A. Nervus cutaneus surae lateralis
- B. **Nervus peroneus communis**
- C. Nervus peroneus superficialis
- D. Nervus tibialis
- E. Nervus peroneus profundus

150. Чоловіка віком 60 років доставлено до приймально-діагностичного відділення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги зі скаргами на двоїння предметів перед очима, асиметрію мимічної мускулатури праворуч, слабкість та оніміння в лівих кінцівках, що виникли гостро близько 4,5 год тому. У неврологічному статусі ліворуч визначається периферичний прозомонопарез, праворуч - геміпарез, гемігіпестезія. Через 20 хв після госпіталізації вище зазначені симптоми регресували. Який режим магнітно-резонансної томографії є найінформативнішим у цьому разі?

- A. **DWI**
- B. T1
- C. STIR
- D. FLAIR
- E. T2